



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صباح شعبان احمد على
المحافظة : الفيوم الحى / المدينة : اطسا
رقم البطاقة : 27901100104881 رقم التليفون : 01003707280
العنوان : م حلفا
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-01-1979 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صباح شعبان احمد علي National ID: 27901100104881	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تعريف الشخصية



صباح
شعبان احمد عنى
د حلف
مركز اطسا - الفيوم

٢٧٩٠١١٠٠١٠٤٨٨١

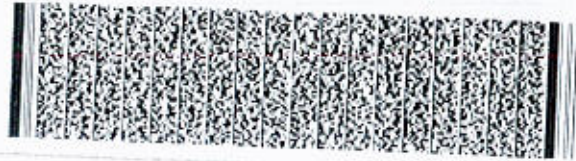
LB2724454



٢٠٢٥/٠٣ ٢٧٩٠١١٠٠١٠٤٨٨١

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
شريف سعيد حسان عبدالجواد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٣/٠٨





MDT FORM

28/7/2025 G

MRN	6790110888
ID	3201/002
Phone	0106800841
Marital status	
Family history	-ve
REASON OF MDT	post operation
al status	46y
ity	-ve

Clinical Data

PR: 8/8			HER 2: -ve	KI67: 101	R	L
Immunohistochemistry:						
st NACT, ACx4-Tx4					TNM	
crkup: Post RT/M					T2 N2	
Residual viable Gr. dec 25%						
5% DCIS						

Findings: Nipple bare, free.
Deep margin free
End: 4/16
T2 N2a

Dr. Hossam
26/7/2025

COME & PLAN: 1- PORT to Rt. C. W. SC. Axilla, IMC
2- Adx 2 bds + AI ± (AM 4/16. in hkt)

SIGNATURE

ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: صباح شعبان احمد علي		
MR. : 5167		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 46-year-old individual with a diagnosis of luminal breast cancer, staged T2N2, who underwent radiation therapy and modified radical mastectomy (MRM) in July 2025. Post-operative management included a combined endocrine therapy regimen of Zoladex and Femara, with an annual assessment of Zoladex efficacy. The patient is currently on a maintenance endocrine therapy plan that includes Zoladex and Femara, with a review of Zoladex effectiveness scheduled for the annual assessment. The patient presents with locally advanced invasive ductal carcinoma (IDC) that is estrogen receptor (ER) 8/8, progesterone receptor (PR) 8/8, and HER2-negative. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) with taxanes was administered in July 2025, followed by radiation therapy and MRM. Post-operative staging was T2N2. The patient is receiving adjuvant endocrine therapy with Zoladex and Femara, and has been prescribed Zometa (denosumab) for bone protection. A recent CT scan in April 2026 revealed mesenteric panniculitis, which is being monitored. The patient is currently on the fourth cycle of adjuvant endocrine therapy as of April 2026. The patient underwent a free CT scan in June 2026, which showed no evidence of disease recurrence. Zoladex was administered today, and Femara was continued as per pharmacy schedule for the next three months.		
تحريراً في ,		
	التاريخ : 20-09-2026	الوقت :
اسماء محمد مصطفى نصر		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

ame : الأستاذة / صباح شعبان احمد على
o. : 27901100104881
: 2230/25
: Female
: 46 Y

J Doc :

Request No. : 13004814
Request Date : 08/07/2025
Verification Date : 12/07/2025
Financial Category : جوماتك روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

ata: Right breast cancer, Post-NACT.

the specimen: Right modified radical mastectomy.

amination:

modified radical mastectomy specimen measured 17x15x4 cm, with covering skin
measured 15x10 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
g showed a tumor bed site measured 2.5x2x2 cm, located 0.2 cm away from the
p margin.
xillary fat measured 7x6 cm, entangling 16 lymph nodes, the largest was 1.5x1x0.5

s:
ome breast tissue., 4&5- TBS., 6:11- Breast tissue., 12- N&A., , 13- Daep margin.,
Ns.
as done by; Dr.Heba Hassan.

ic examination:

cal type: Residual viable invasive duct carcinoma
nour size 2.5x2 cm) (Cellularity 25%).
(differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
mediate grade DCIS (Cribriform & comedo patterns).

asion: Present.

al Invasion: Not detected.

id areola: Free.

rgin: Free.

mph nodes: Positive viable metastatic deposits involving four out of sixteen
es (The largest nodal mets ,measuring 2 mm in maximum dimension, with extra-
asion) (4 /16).

ified by :

Duaa Mohamed

: 26/07/2025 09:02:58

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name : الأستاذ / صباح شعبان احمد على
No. : 27901100104881
Age : 2230/25
Sex : Female
Age : 46 Y
ing Doc :
Request No. : 13004814
Request Date : 08/07/2025
Verification Date : 12/07/2025
Financial Category : نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

ogic response to therapy: Pathologic partial response to therapy.

sis:

reast cancer (Post-NACT), Right modified radical mastectomy:
al viable invasive duct carcinoma, Grade 2 (Cellularity 25%) (Actual tumor size 2.5x2

termediate grade DCIS (Cribriform & comedo patterns).

and areola: Free.

margin: Free.

y lymph nodes: Positive viable metastatic deposits involving four out of sixteen
odes (The largest nodal mets, measuring 2 mm in maximum dimension, with extra-
xtension) (4 /16).

ypT2, ypN2a.

3.194, RCB class-II.

ature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba Hassan Adly.

erified by :
Dr. Duaa Mohamed

ate : 26/07/2025 09:02:58

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

PATIENT NAME: SABAH SHABAN AHMED ALI
GENDER: Female
DATE : 15-Dec-2024 10:26 AM

PATIENT ID: 10124254249
AGE: 45 y
ORDER: 3165902,3166097

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- right breast cancer

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV non-ionic contrast medium infusion 100 ml of omnipaque

REPORT:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate symmetrical background parenchymal enhancement.
- Right UOQ mass showing marked heterogenous mass enhancement measured 4x2.7x3.5 cm, with anterior ductal extension extending 4.3 cm anterior to the lesion being 1.2 cm from the nipple. The area is measured collectively 7.6x4.8 cm. the area is seen 0.6 cm from the overlying skin.
- Left UIQ 12:00 asymmetrical regional faint heterogeneous non-mass enhancement, that showed increased uptake in delayed images, measuring 5.7x4x2.7 cm, seen 3.2 cm from the nipple. US showed underlying confluent of normal caliber ducts with internal echogenic avascular contents seen 0.48 cm from the overlying skin
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Right single prominent level I axillary lymph node showing diffuse cortical thickening reaching 0.22 cm and preserved hilum ?? Indeterminate

OPINION:

- right breast UOQ mass with pathological mass and anterior non-mass enhancement with ipsilateral indeterminate axillary lymph node (BIRADS 6).
- left UIQ 12:00 asymmetrical non-mass enhancement of underlying normal caliber ducts with internal ?? inspissated secretion ?? Soft tissue growth. For tissue biopsy (BIRADS 3)

Reported By,

Dr. Yasmin Nada, MSc

15-Dec-2024 11:18 AM

PATIENT NAME: SABAH SHABAN AHMED ALI

GENDER: Female

DATE : 28-Nov-2024 10:56 AM

PATIENT ID: 10124254249

AGE: 45 y

ORDER: 3142590,3142591

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN
AND PELVIS WITH TRIPHASIC ASSESSMENT OF THE LIVER:****TECHNIQUE:**

- Multislice helical CT acquisition with automatic IV low osmolar non-ionic contrast medium infusion 50 ml.

FINDINGS:**-Pathologically proven right breast IDC.****1-CHEST**

- Right breast UOQ ill defined heterogeneously enhancing lesion measuring about 2 x 2.7 cm seen abutting the underlying pectoralis major muscle.
- Few prominent right axillary level I, II and to lesser extent level III lymph nodes; the largest is at level I measuring 0.8 cm in the shortest axis.
- Few small right supraclavicular lymph nodes the largest measures 0.6 cm.
- Bilateral pulmonary few scattered nodules; the largest is at the left lower lobe measuring about 0.4 cm.
- Mosaic pulmonary attenuation
- No pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Few small right cardiophrenic lymph nodes; the largest measures about 0.9 x 0.4 cm.
- No CT evidence of another pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- Enlarged liver showing enlarged left hepatic lobe. No definite hepatic

PATIENT: SABAH SHABAN AHMED ALI, 10124254249, Female, 45 y

Report version 2, 28-Nov-2024 07:36 PM

Page 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الزلم
في شارع عادية اول شارع خورم بدور داري، الجيزة
د. زكريا روية والشيخ زايد
الطبي الأول - الشيخ زايد امام كلية الهندسة

- Opinion:**

- Reported By,
Toka Elbehairy, MSc
Dr. Mahmoud Ibrahim, MD

PATIENT: SABAH SHABAN AHMED ALI, 10124254249, Female, 45 y
Report version 2, 28-Nov-2024 07:36 PM